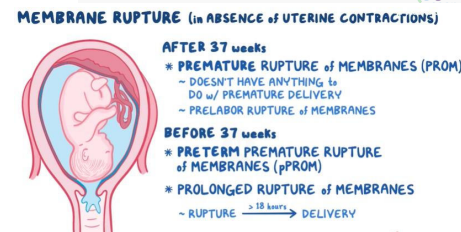
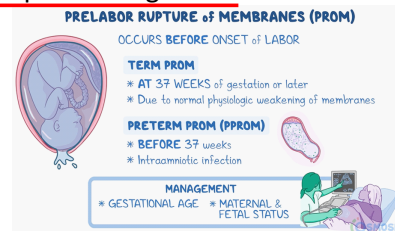


LA RUPTURE PREMATUREE DES MEMBRANES

I. INTRODUCTION :

- RPM = **Rupture** franche de l'**amnios** et du **chorion**, avant le début du travail quel que soit l'âge de la grossesse. → Repère = Travail
 - On inclut les fissurations de la poche des eaux
 - On exclut les ruptures en cours de travail.
- Fréquence élevée** : 6 à 12 % des grossesses
 - 30 à 40 % des accouchements prématurés
 - la rupture se produit après 37 SA: 70%
 - la rupture se produit entre 34 et 37 SA: 20%
 - elle se produit avant 34 SA: 10%
 - Avant 28 SA, RPM exceptionnelles (1 à 7/1 000 grossesses),
- Les conséquences sont plus importantes que la grossesse est jeune**
 - à l'âge gestationnel à la naissance → **Risque de prématurité**
 - aux risques infectieux → **Infections périnatales**



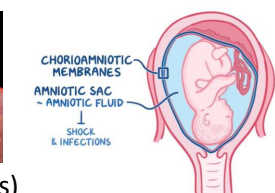
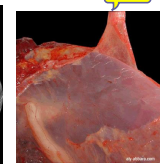
La conduite à tenir diffère selon l'âge auquel survient la rupture

Avant 28 SA :	Entre 28 et 37 SA :	Après 37 SA :
<u>-Pronostic vital maternel</u> <u>-Question : Poursuite de la grossesse ???</u>	<u>La CAT dépend de la balance entre le risque infectieux et celui de la prématurité.</u>	<u>Le risque est infectieux ;</u> <u>L'accouchement doit se faire :</u> <u>Déclenchement, activation,</u> <u>Césarienne ???</u>

II. PHYSIOPATHOLOGIE :

A. Structure des membranes :

- Membranes fœtales :
 - L'amnios** : Membrane interne, avasculaire, non innervée (Glycogène + Glycoprotéines)
 - Le chorion** : Membrane externe (Collagène)
 - La couche spongieuse** : entre les deux, assure le glissement entre l'amnios et le chorion.



B. Rupture des membranes :

- Normalement** : il existe un équilibre entre les processus de dégradation et de renouvellement des membranes
- La rupture** : = amincissement focalisé des membranes SOUVENT en regard du col utérin.
- Les causes** : = Enzymes (protéases ; trypsine, élastases, protéinase ; proteoglycanases).

C. Facteurs favorisants :

- Facteurs mécaniques** :
 - Au troisième trimestre: membranes sont de plus en plus distendues, amincissement généralisé des membranes et une diminution de leur élasticité qui diminuent leur résistance (Hydramnios; grossesses gémellaire..;etc.)
 - Ruptures iatrogènes:
 - Modifications du col:
- Rôle de l'infection** :
 - Cervico-vaginale par voie ascendante.
 - Infections urinaires : → **Libération directe des protéases, Enzymes bactériennes**

D. AUTRES :

- Age maternel avancé
- Multiparité
- Bas niveau socio-économique
- Travail pénible
- Tabagisme

III. ETIOLOGIES :

QE!!

1 - Les infections : -Infections cervico-vaginales : ▪ Les germes : produisent les collagénases ▪ Macrophages : Production des enzymes (Protéases; Elastases...etc.) -Infections urinaires : 7 des CU	2 - Les béances cervico-isthmiques : -Hernie des mbr dans canal cervical - Traumatisme des membranes (Infections vaginales, Rapports sexuels, TV...etc.)	3- Anomalies du placenta : Le placenta prævia
4 - Les causes iatrogènes : -Amniocentèse -Biopsies trophoblastiques -Ponction de l'hydramnios	5 - Les causes mécaniques : -Grossesses gémellaires -Présentations irrégulières -Présentations du siège -Disproportions foeto-placentaires	

IV. DIAGNOSTIC POSITIF :

A. Clinique :

1. Souvent : Dans 80%, le diagnostic est évident

a. Signes fonctionnels :

- Perte **soudaine** en **dehors** du **travail** d'un liquide eau de roche

- Liquide **chaud** ; **abandon, continu, exagère** à la **mobilisation** de l'utérus (Signe de Tarnier) **ou** du fœtus

- Les signes généraux sont absents

- Il faut prendre température pour rechercher une infection

- L'abdomen est souple

b. A l'examen :

- Mesure de la Hauteur utérine (HU), BCF

- Examen vaginal avec un speculum stérile :

▪ On peut voir du liquide sourdre du col

▪ Mobiliser la présentation

▪ Demander à la patiente de pousser

→ Ecoulement du liquide

-Le toucher vaginal (TV) n'est **pas systématique**

-Le nombre de TV doit être limité ++++

▪ (Risque infectieux)

▪ Si non **un gant stérile** doit être utilisé :

✗ Pas de membranes

✗ Etat du col + présentation

✗ Faire des **prélèvements** bactériologiques

✗ Il faut éliminer une **procidence** du cordon +

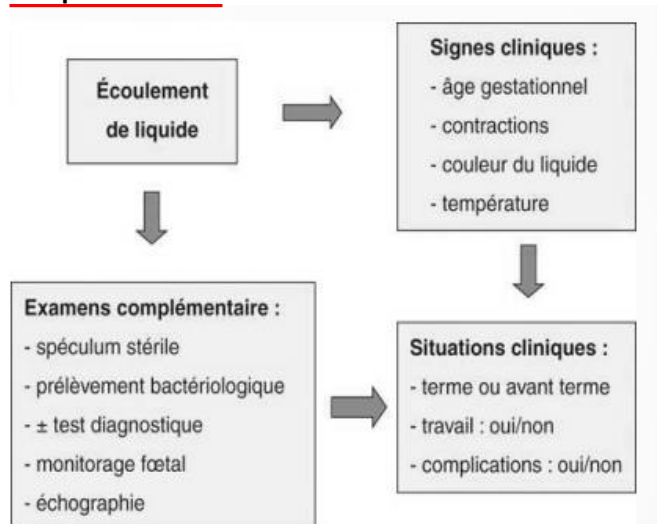
2. Parfois :

A l'examen : diagnostic moins évident

-L'écoulement est **moins abondant** ; **intermittent**, et qui prête **confusion** a des **urines** ou des **leucorrhées**.

-Devant un écoulement minime ; il faut éliminer une rupture en cas d'oligoamnios ou une fissure des membranes

-**Dans ces cas difficiles : intérêt des examens complémentaires**



B. Examens paracliniques :

Les tests :

Intitules si rupture est évidentes.

• Mesure du pH vaginal (= test à la nitrazine) :

-Normalement le pH est acide (Entre 4,5-6)

-En cas de RPM ; le pH devient basique (Ph du LA=7,2)

→ papier à pH ou par le test à la nitrazine ou Amnicator®

Excellente sensibilité, de plus de 90 %

-Si test est négatif, il élimine pratiquement une RPM

• Recherche de squames fœtales : Les cellules fœtales sont fluorescentes au microscope à fluorescence

• Amnios-infusion : Injection en intra-utérin d'un sérum physiologique avec un colorant

• Test à la D amine-oxydase (DAO) : La DAO est sécrétée par le placenta à partir de 20 SA

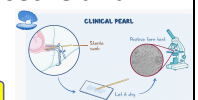
• Test de cristallisation : Sensibilité de 90 %

Liquide amniotique étalé sur une lame et séché à l'air libre

→ Test : + si :

✓ Cristallisation arborescente.

✓ Sensibilité à 90 %



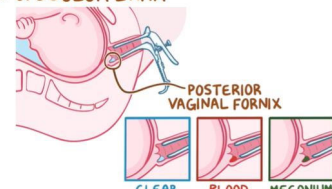
2. L'échographie :

• Peut constituer une aide au diagnostic

• Elle permet d'apprécier la quantité du LA

Šamsôdés Doctr 3-Amnioscopie :

* SPECULUM EXAM



* AMNIOTIC FLUID

* NITRAZINE TEST

pH > 7.1 = POSITIVE

* FERN TEST



V. CONSEQUENCES DE LA RUPTURE PREMATURÉE DES MEMBRANES :

A. Mise en route du travail :

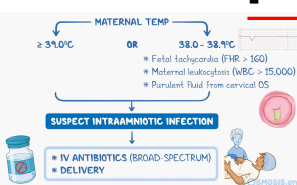
- En cas de rupture de la poche des eaux, il y a une libération des prostaglandines
- Conséquences : Avant terme ; 50 % des femmes accouchent en 5 heures ; plus de 95 % dans les 24 heures.

B. La prématurité :

- C'est la complication majeure et la plus risquée (Entrée spontanée en travail).
- Si menace d'accouchement prématurée (MAP) + RPM : Question : Tocolyse ou non ?????

C. L'infection :

- Elle est souvent la cause de la RPM et parfois la conséquence
- Risque majeur : La chorio-amnionite
 - Le LA sera très rapidement contaminé par les germes d'origine vaginale
 - Le risque infectieux augmente avec : La durée de la rupture : 25 % de culture positive à 6 heures de rupture, 50 % après 20 heures
- Cliniquement :
 - La chorio-amnionite est certaine si association de deux signes suivants :



× Sensibilité utérine

× Tachycardie maternelle (> 100 BPM)

× Tachycardie fœtale (>160 BPM)

× CRP élevée

→ Toute fièvre avec RPM sans foyer évident est une chorioamniotite jusqu'à preuve du contraire

> La fièvre maternelle >38° isolée
> A l'association d'une fièvre + 2 des critères suivants :

- HyperGB maternelle >15 G/l
- Tachycardie maternelle >100 bpm
- Tachycardie fœtale >160 bpm
- Douleur à la palpation utérine
- Odeur malodorante du liquide amniotique

PREMATURE RUPTURE of MEMBRANES

* INFECTIOUS CONSEQUENCES

** PROLONGED RUPTURE of MEMBRANES

~ INTRAUTERINE INFECTIONS

VAGINAL FLORA

GRAM NEGATIVE LACTOBACILLI

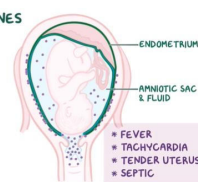
ANAEROBIC BACTERIA

GROUP B STREPTOCOCCUS

~ VAGINAL & RECTAL SWABS

ENDOMETRITIS

CHORIOAMNIONITIS



D. Autres conséquences :

1 -Fœtales :	2 - Maternelles :
<u>Avant 37 SA : = Conséquences de l'oligo-amnios :</u> - Hypoplasies pulmonaires - Déformations par compressions : nez et oreilles aplatis ; oreilles bas implantées, pieds varus, pieds bots ; luxation de la hanche - Ankylose des membres par immobilisation prolongée - RCIU ...Etc.	- Septicémies - Infections du post-partum - Retentissement socio-professionnel et familial ; → Hospitalisations prolongées - Taux des césariennes élevé
<u>Après 37 SA :</u> - Procidence du cordon - Présentations dystociques - Compressions funiculaires	

VI. PRISE EN CHARGE :

A. Principaux objectifs :

- Lutter contre :
 - La prématurité
 - L'infection materno-fœtale.
- Complications néonatales sont liées à :
 - La prématurité
 - Temps écoulé entre la R.P.M et accouchement

DONC :

- Près du terme :
 - C'est le risque infectieux qui prédomine
 - Moment et voie d'accouchement** : Vois basse ou voie haute ?????
- Loin du terme :
 - Risque infectieux, prématurité et Oligoamnios

B. Hospitalisation : Quelle que soit l'Age de la grossesse

Buts :

- Evaluer et dépister le risque infectieux.
- Apprécier la maturité fœtale

1. Evaluer le risque infectieux :

A - Surveillance clinique :

-Obligatoire et régulière (Température, état clinique, Pouls...etc.)

-Rechercher :

Une fièvre / Une tachycardie fœtale/ Une tachycardie maternelle/ Aspect du liquide amniotique : teinte, purulent...etc.

Cependant, tous ces signes = DIAGNOSTIC TROP TARDIF DUNE CHORIOAMNIOTITE

B - Surveillance biologique :

Prélèvement vaginal bactériologique (sous speculum stérile)

ECBU(1 PV-ECBU par semaine), NFS plaquettes+CRP(2-3*/sem)

C - Surveillance électrocardiographique fœtale

(RCF): Pour dépister une souffrance fœtale

2. Appréciation de la maturité fœtale :

- Echographie obstétricale :

- Etudie la morphologie,
- Etudie la vitalité fœtale,
- Etudie l'état du bien être fœtal,
- Etudie la biométrie,

- Etudie les annexes,
- Etudie le LA (oligoamnios),
- Mesure De La Longueur Cervicale ?.

C. La conduite pratique :

1. Les moyens :

a - L'antibiothérapie :

- **Préventive** : Son bénéfice est prouvé

- Elle diminue le risque infectieux maternel et néonatal
- Elle prolonge la grossesse
- Antibiothérapie préventive est obligatoire :
 - Valvulopathie rhumatismale
 - Corticothérapie
 - R.P.M > 12 heures
 - R.P.M avec un travail prolongé

➔ une AMOXICILLINE

-Les ATB à privilégier sont les pénicillines ou les ATB macrolides (érythromycine) sous forme parentérale et/ou orale. Chez les patientes allergiques à la pénicilline, les ATB macrolides devraient être utilisés seuls.

-L'amoxicilline/ acide clavulaniques ne devrait pas être utilisée en raison du risque accru d'entérococolite nécrosante que courent les nouveau-nés exposés à cet ATB. L'amoxicilline utilisée sans acide clavulanique est sûre.

-Les femmes qui connaissent une RPMP devraient faire l'objet d'un dépistage visant les infections des voies urinaires, les infections transmissibles sexuellement et le statut de porteuse de streptocoques du groupe B, et elles devraient être traitées au moyen d'ATB appropriés lorsque ce dépistage donne des résultats positifs.

- **Curative** :

- En cas de chorio-amnionite
- EN URGENCE ; faire :
 - Faire des prélèvements à visées bactériologiques du LA, placenta...etc.
 - Démarrer une antibiothérapie 2 à 3 antibiotiques par voie parentérale à large spectre (Amoxicilline + Gentamycine +/- Métronidazole OU Ceftriaxone + Gentamycine ...)

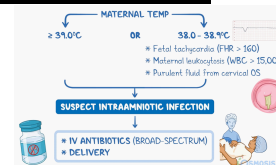
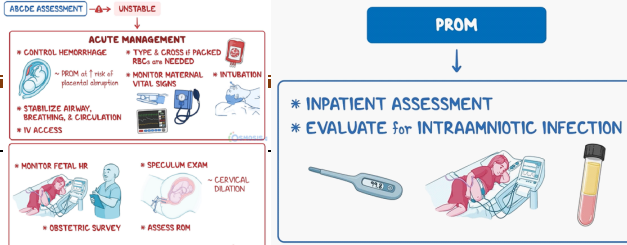
b - La tocolyse :

- Très discutée** :

- Thérapeutique en cas de contractions utérines
- En raison du risque infectieux élevé (Si Contractions utérine présentes, il faut éliminer une chorioamnionite)
- But : Retarder l'accouchement pour donner une corticothérapie pour accélérer la maturité pulmonaire fœtale.

- Contre-indiquée SI** :

- Chorioamnionite
- Souffrance fœtale aigue ou chronique
- MFIU
- Risque vital maternel...etc.



c - La corticothérapie :

AVANT 34 SA :

- Accélère le développement du tissu pulmonaire fœtal
- Diminue le risque d'hypoplasie pulmonaire : Par conséquent elle diminue les risques de détresse pulmonaire ; d'hémorragie intra-ventriculaire et de mortalité néo-natale...etc.
- On utilise la **Bétaméthasone** : 12 mg en injection intramusculaire à répéter 24 Heures après.

QE!!

2. Prise en charge en fonction de l'âge gestationnel :

• 1 - Avant 28 SA :

-HOSPITALISATION

- Expliquer aux parents les risques materno-foetaux
- La surveillance est longue pour arriver à une maturité fœtale, donc le pronostic est mauvais
- Antibioprophylaxie : OUI
- Tocolyse : NON
- Corticothérapie : NON
- Si pas de complications, pas de facteurs de risques : proposer une hospitalisation à domicile avec une AUTO-SURVEILLANCE.

• 2 - Entre 28 SA et 34 SA :

- HOSPITALISATION
- Surveillance jusqu'à maturation foetale
- Antibiothérapie de courte durée ????
- Tocolyse si contractions utérines ????
- Corticothérapie
- Eventuel transfert in utero

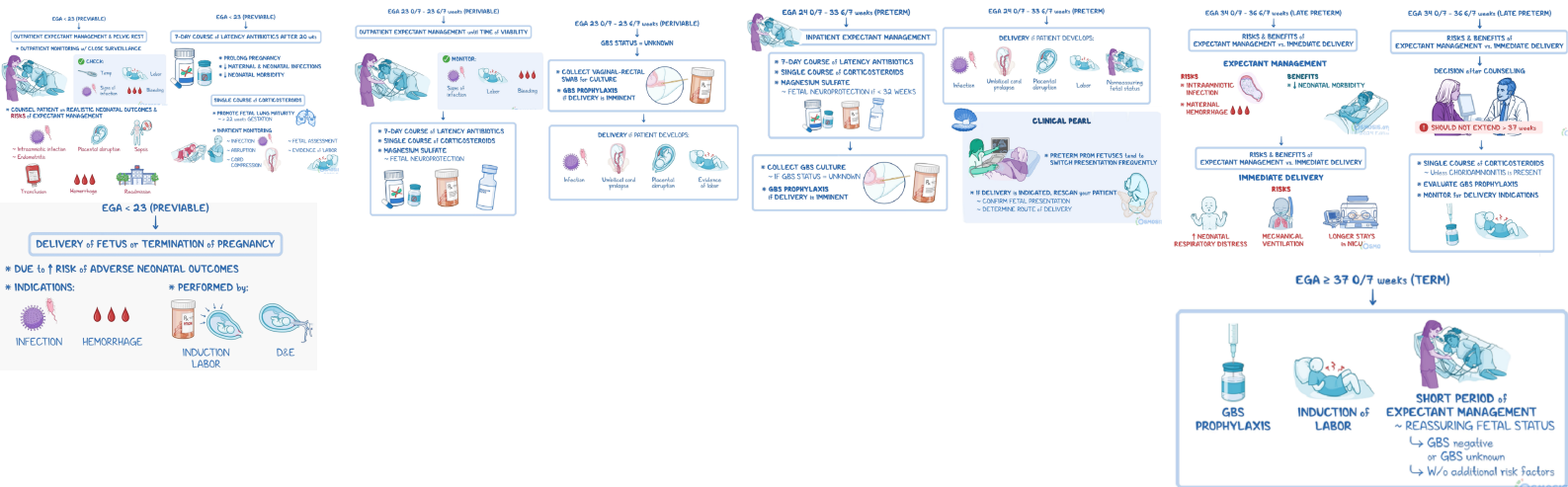
• 2 - Avant 34 et 37 SA :

-HOSPITALISATION

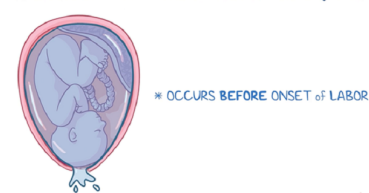
- La surveillance est COURTE,
- Antibiothérapie : OUI
- Corticothérapie : ????
- Pas de tocolyse
- Si risque maternel ou fœtal : L'accouchement doit se faire en urgence

• 3 - Après 36 SA :

- L'accouchement doit se faire en urgence
- Question ??? : Déclenchement / Activation/ Césarienne
- Si contractions utérine : Diriger le travail
- Si pas de contraction utérine : Antibiothérapie, déclenchement du travail, accouchement par voie basse ou par haute ???
- Si chorio-amnionite : Antibiothérapie curative et une extraction fœtale d'urgence.



PRELABOR RUPTURE OF MEMBRANE (PROM)



ASSESS for INTRAAMNIOTIC INFECTION

PRESENT



ASSESS for INTRAAMNIOTIC INFECTION

